

■ 回復期リハ／脳卒中×デジタル

回復期の脳卒中高齢者、14日間の機器指導で 完遂者の74%が全7課題を自立

国内の回復期病棟・単施設の実現可能性研究 比較群なし、完遂19人

単施設の前向き実現可能性研究。65歳以上の脳卒中患者に、前半7日は療法士が支援する指導、後半7日は自主練習の計14日間。タブレット・チャット・ビデオ通話・ウェアラブル機器の7課題を毎日5段階で評価した。

完遂した19人(平均76.3歳、女性9人、MMSE平均26.1点)のうち、14日目に

全課題を自立したのは14人(74%)。タブレット・ウェアラブルの管理と基本操作は18人(95%)、チャットは15人(79%)、ビデオ通話は14人(74%)が自立し、通話系がやや難しかった。

比較群なし・19人・単施設・短期で、機能の高い人が対象(登録数・脱落は抄録に記載なし)。上達

が指導の効果か慣れかは区別できず、退院後の継続利用も未確認。



退院前のデジタル支援は実施できる、効果の検証はこれから

出典 **JMIR Formative Research** ↗

数字で見る

19人
14日間のプログラム完遂者(単施設)

74%
14日目に全7課題を自立(1日目は0人)

57.8点
SUS平均(使いやすさは「中等度」)

■ 嚥下障害／服薬

とろみ付きなら安全な患者でも、 服薬時の33%で液体が侵入・誤嚥

とろみなしの液体を使うと侵入・誤嚥のオッズ比は4.40。小さい錠剤(3.19)も有意だが、著者らは、慎重な嚥下が要る患者に小さい錠剤を選ぶ「適応による交絡」の可能性が高いとする。

喉頭蓋の形が中間型だと喉頭蓋谷への残留と関連(単変量)。信頼区間は抄録に記載なし。液体が安



全でも服薬場面は別に評価する必要があるようだ。

出典 **Progress in Rehabilitation Medicine** ↗

■ 心臓リハ／身体機能評価

高齢の心筋梗塞、SPPBの歩行速度が 1点高いと心血管リスクは約半分

対象はSPPB 4～9点の65歳以上で、多面的リハ群と通常ケア群に2対1で割付。ベースラインSPPBが低いほど主要評価項目のリスクは高く(HR 0.51、95%CI 0.32-0.82)、項目別では歩行速度が最強の予測因子(HR 0.50、95%CI 0.37-0.68)だった。

SPPBと介入の交互作用はなく、リハの効果は水



準を問わず一貫。追跡中に1点以上改善した人は有害事象が少なかった(観察的な関連)。対象はSPPB 4～9点に限られる。

出典 **Eur J Prev Cardiol** ↗

短 信

〈回復期管理〉**在院日数のずれ、施設より保険・地域**

米国の入院リハ24.3万件。保険の種類・時期・地域が上位で、施設特性は小さい 出典 **J Am Med Dir Assoc** ↗

〈呼吸リハ〉**COPDの倦怠感、L-アルギニン等の併用で軽減**

在宅酸素のCOPD98人のRCT。FSS差-0.90、6分間歩行など副次は差なし 出典 **Thorax** ↗

〈口腔・嚥下〉**基本チェックの口腔3項目、死亡リスクと関連**

岡山市の高齢者約5万人。スコア3でaHR 1.49、口渇は関連なし 出典 **J Am Geriatr Soc** ↗

〈心臓リハ〉**スマートリング併用の在宅心リハ、VO2が上乗せ**

64人のRCT。ピークVO2の群間差2.0mL/kg/min(95%CI 0.7～3.3) 出典 **J Korean Med Sci** ↗

〈心不全〉**HFpEFの運動、複合トレーニングが有力**

15RCT・1,554人のネットワークMA。複合運動でピークVO2 +2.61mL/kg/min 出典 **ESC Heart Fail** ↗

〈医療AI〉**カルテからLLMで移動機能を抽出、入院と関連**

60歳以上2,994人。移動障害3つ以上で入院aOR 2.35、死亡は非有意 出典 **J Am Geriatr Soc** ↗

〈嚥下×AI〉**認知症の嚥下スクリーニングを予測するML**

620人。外部検証のAUC 0.889～0.900、単独での診断には使えない 出典 **Clin Interv Aging** ↗

〈脳卒中〉**地域の脳卒中チームの教育、社会参加が改善**

後ろ向き163人。FAIの変化+6.02対+1.62、運動WS併用でさらに大 出典 **NeuroRehabilitation** ↗